

АДАПТИВНІ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ ПАЦІЄНТІВ ДО ПЛАСТИКИ ВЕЛИКИХ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ВЕНТРАЛЬНИХ ГРИЖ З ВТРАТОЮ ДОМЕНУ

Кузнецов Олексій Олександрович

Науковий керівник: д.мед.н., професор Білянський Л. С.

Кафедра хірургії №1

Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Пойда О. І.

НМУ імені О.О. Богомольця

м. Київ, Україна

Вступ: Післяопераційна грижа — поширене ускладнення оперативних втручань на органах черевної порожнини, яке спостерігається у 5,1-31,8% пацієнтів [1]. За класифікацією Європейського товариства герніологів (EHS): велика вентральна грижа визначається як дефект черевної стінки понад 10 см в ширину ($W3 > 10\text{cm}$) [2]. Проте, в хірургічній практиці зустрічаються дефекти значно більшої ширини, лікування яких потребує спеціальних технологій — методів профілактики ускладнень, пов'язаних з внутрішньочеревною гіпертензією та дихальною недостатністю. Особливої уваги заслуговують дефекти черевної стінки, які перевищують ширину в 10 см, коли значна частина органів черевної порожнини знаходиться поза її межами. Такий стан отримав назву «loss of domain» (LOD) або втрата домену. Він визначає співвідношення об'єму грижового мішка, який знаходиться поза межами черевної порожнини, до об'єму самої черевної порожнини. Формулу для розрахунків запропонував Такака і співавт. у вигляді індексу, що визначається за допомогою комп'ютерної томографії черевної порожнини [3]. Зменшений об'єм черевної порожнини, пов'язаний з хронічною латеральною ретракцією (латералізацією) прямих м'язів живота, унеможлиблює первинне фасціальне закриття внаслідок високого потенційного ризику розвитку внутрішньочеревної гіпертензії, абдомінального компартмент-синдрому, гострого респіраторного дистрес-синдрому та високої ймовірності рецидиву грижового дефекту. Через це дана категорія пацієнтів потребує особливої передопераційної підготовки, до якої належить застосування

адаптивних методик, а саме, прогресуючого пневмоперитонеуму (PPP) та медикаментозної релаксації бокових м'язів живота за допомогою ін'єкцій ботулотоксину А (ВТА).

Мета: Покращення результатів лікування хворих з великими дефектами черевної стінки з LOD, завдяки застосуванню комбінації адаптивних методів периопераційної підготовки.

Матеріали і методи: Процедура PPP проведена загалом у 45 пацієнтів: у 19 пацієнтів на початкових етапах дослідження, до 2019 року, PPP проводився без застосування ВТА. У 26 випадках PPP використовували через 2 тижні після введення ВТА за стандартним протоколом (загалом 200-300 Од у 3 точках по передній пахвовій лінії з обох боків). Середній об'єм введенного повітря в обох групах склав 8500 ± 3400 см³, протягом $12,3 \pm 2,5$ днів (від 9 до 15 днів). Крім зазначених периопераційних методів підготовки, 18 пацієнтам виконано інтраопераційний пролонгований фасціальний натяг за допомогою модифікованого апарату fasciotens .

Результати: Застосування всього комплексу представлених методик, а саме: введення ботулотоксину А, проведення передопераційного прогресуючого пневмоперитонеуму та інтраопераційний пролонгований фасціальний натяг; виконано у 18 пацієнтів з дефектами черевної стінки у стані loss of domain. Ширина дефекту складала $25,8 \pm 6,5$ см та індексом Танака від 25% до 30%. Внаслідок проведеної адаптивної підготовки у всіх без виключення хворих після завершення процедури фасціального натягу зводились краї дефекту, що дозволило завершити оперативні втручання з хорошим функціональним результатом.

Висновок: Отримані результати відповідають даним літератури і підтверджують, що комбінація адаптивних периопераційних методів PPP та ін'єкцій ВТА з інтраопераційним пролонгованим фасціальним натягом — цілком виправданий підхід у підготовці пацієнтів до пластики великих вентральних гриж з втратою домену, який суттєво підвищує ймовірність успішного первинного фасціального закриття.

Ключові слова: велика інцизійна грижа, втрата домену, прогресивний пневмоперитонеум, ботулотоксин А

Список літератури:

1. Smith, L., Wilkes, E., Rolfe, C., Westlake, P., Cornish, J., Brooks, P., & Torkington, J. (2024). Incidence, Healthcare Resource Use and Costs Associated With Incisional Hernia Repair. *Journal of abdominal wall surgery : JAWS*, 3, 12452. <https://doi.org/10.3389/jaws.2024.12452>

2. Muysoms, F. E., Miserez, M., Berrevoet, F., Campanelli, G., Champault, G. G., Chelala, E., Dietz, U. A., Eker, H. H., El Nakadi, I., Hauters, P., Hidalgo Pascual, M., Hoeferlin, A., Klinge, U., Montgomery, A., Simmermacher, R. K., Simons, M. P., Smietański, M., Sommeling, C., Tollens, T., Vierendeels, T., ... Kingsnorth, A. (2009). Classification of primary and incisional abdominal wall hernias. *Hernia : the journal of hernias and abdominal wall surgery*, 13(4), 407–414. <https://doi.org/10.1007/s10029-009-0518-x>

3. Tanaka, E. Y., Yoo, J. H., Rodrigues, A. J., Jr, Utiyama, E. M., Birolini, D., & Rasslan, S. (2010). A computerized tomography scan method for calculating the hernia sac and abdominal cavity volume in complex large incisional hernia with loss of domain. *Hernia : the journal of hernias and abdominal wall surgery*, 14(1), 63–69. <https://doi.org/10.1007/s10029-009-0560-8>